

人工尿道括约肌 (AUS)

患者须知 · AUS手术前须了解的信息

WARWIKI

人工尿道括约肌（AUS）是一种完全植入皮下的小型装置，用于在您因漏尿——最常见于前列腺手术后——无法控制排尿时恢复膀胱控制。您可通过阴囊内隐藏的泵自行操控。本手册介绍其工作原理、术前准备及术后注意事项。

关于本手术

活动、咳嗽或提重物时漏尿称为**压力性尿失禁**，常见于前列腺手术后。AUS通过三个相互连接、全部隐于皮下的部件来治疗这一问题：

- 围绕尿道（排尿管道）的柔软**袖套**，通过轻柔夹闭尿道防止漏尿
- 位于阴囊中的**泵**，需要排尿时按压
- 位于下腹部的小型**储液囊**，用于维持适当压力

使用方法：平时袖套保持关闭，防止漏尿。需要排尿时，多次挤压并松开泵——袖套即打开，您可排尿。几分钟后袖套自动重新充盈并关闭。

安全吗？

AUS是治疗此类漏尿的长期金标准方案，大多数患者可获得良好的尿控效果。与所有植入物一样，存在一定风险——主要包括感染，或装置及尿道随时间磨损需后期修复。医疗团队将通过抗生素、无菌操作及术前控制尿路感染来降低感染风险。

名词解释

压力性尿失禁

活动、咳嗽或提重物时发生的漏尿。

尿道

将尿液排出体外的管道。

袖套

装置中轻柔夹闭尿道、防止漏尿的部件。

泵

位于阴囊中、按压后可打开袖套以排尿的部件。

激活

术后约6周愈合后，在诊室开启装置。

停用

关闭装置（袖套保持开放）——任何导尿前均须停用。

全身麻醉

手术期间使您保持睡眠状态、感觉不到疼痛的麻醉药物。

膀胱镜检查

术平常进行的对尿道及膀胱的摄像机检查。

会疼吗？ 手术在全身或脊椎麻醉下进行，术中无感觉。术后阴囊及阴囊与肛门之间区域会有酸痛、肿胀和瘀伤，持续约两周——阴囊托、冰敷和止痛药有助于缓解。手术约需1-2小时，许多患者当天即可回家。

术前准备

- 手术在**全身或脊椎麻醉**下进行——请严格遵守手术须知（禁食要求及需暂停的药物，包括抗凝血药）。
- **尿液检测**排查感染——如有感染须先治疗，手术可能需要重新安排。
- **请勿吸烟或使用电子烟**；用医疗团队提供的**消毒皂**沐浴，并按要求服用抗生素——这是植入物手术，预防感染至关重要。

请提前告知您的医疗团队以下情况：

- 曾接受过**盆腔放疗**，或曾行尿道或尿失禁手术
- 患有**糖尿病**，或手部操作不便（泵需自行操控）
- 身体任何部位存在感染

手术过程

- 1 麻醉后您将处于睡眠状态或腰部以下失去知觉，同时给予抗生素。
- 2 医生通过小切口将**袖套**置于尿道周围，将**储液囊**置于下腹部，将**泵**置于阴囊——全部位于皮下。
- 3 装置充盈并测试后，**保持关闭状态**以待愈合。

术后注意事项

- 阴囊及会阴部**肿胀和瘀伤**持续约1-2周。请使用阴囊托、冰敷，并遵医嘱避免**重体力劳动、用力排便、骑车及性生活**。
- **装置关闭约6周**。此期间仍会漏尿，请继续使用护垫——这是正常现象。**在医生激活前请勿按压泵**。
- 约**6周后复诊时**，医生将开启装置并教您如何使用泵。
- **务必告知所有医疗人员您装有AUS**——任何导尿前须先停用装置，否则可能损伤尿道。请随身携带医疗警示卡。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热、寒战，或切口部位**红肿、疼痛加重**或有分泌物
- 突然完全无法排尿
- 阴囊明显**肿胀、变硬或疼痛加剧**

需要记住的三件事

1. AUS是隐于皮下的装置，可恢复膀胱控制——袖套保持干燥，按压阴囊中的泵即可排尿。
2. 装置**关闭约6周**（此期间仍会漏尿——这是正常的），之后开启并教您使用。
3. 预防感染最重要：术前控制感染、戒烟、使用消毒皂和抗生素。**务必告知所有医疗人员您装有AUS**——导尿前须先停用装置。